

URGENCIAS FARINGOLARÍNGEAS

CUERPOS EXTRAÑOS

FARÍNGEOS

R. Gómez-Blasi Camacho, L. López Flórez, C. Martín Oviedo.

- Importancia de la historia para establecer el grado de sospecha y la localización
- Las radiografías de rutina no están indicadas

Introducción

La ingestión de un cuerpo extraño es una patología que con frecuencia se considera banal por el paciente, pero que ocasionalmente puede dar lugar a complicaciones que comprometan la vida del mismo. Es una situación que encontraremos a menudo en las urgencias, y que, dependiendo de su localización, puede ser resuelta o no sin necesidad de especialistas. Es fundamental establecer el grado de sospecha para distinguir entre posibles cuerpos extraños, que debemos buscar con energía y otras sensaciones más crónicas y difusas que podemos estudiar de forma ambulatoria.

Son frecuentes en los niños, tanto de forma voluntaria como involuntaria, donde puede ser difícil su diagnóstico y lo sospecharemos mediante la anamnesis. En la mayoría de adultos, por otra parte, se trata de un hecho accidental que nos indican ellos mismos. El tratamiento consiste en su extracción, requiriendo en ocasiones anestesia general en función de la localización, nivel de impactación y edad del paciente (1).

Diagnóstico

Historia Clínica

En primer lugar debemos interrogar al paciente sobre la intensidad, calidad y tiempo de evolución de su sensación. Un cuerpo extraño suele producir una sensación aguda, bien definida y con un origen concreto, normalmente coincidiendo con una comida. Una molestia más crónica, con un origen difuso, es poco probable que se deba a un cuerpo extraño.

Pediremos que se señale “a punta de dedo” donde nota la sensación. Los cuerpos extraños suelen producir un dolor bien localizado, punzante y que aumenta con la deglución. Si la zona es más difusa y es descrita como una molestia en lugar de como dolor, es menos probable que la cause un cuerpo extraño.

La localización es importante también de cara al manejo. Si señala la zona del ángulo de la mandíbula, probablemente se encuentre clavado en las amígdalas o la base de lengua. Si señala la zona de la nuez, estará en la epiglotis, senos piriformes o la boca de Killian y necesitaremos hacer una laringoscopia indirecta o fibroscopia para verlo y extraerlo. Si señala el esternón, se tratará de un cuerpo extraño esofágico.

Debemos prestar atención a algunos síntomas acompañantes. Afagia y sialorrea sugieren impactación esofágica. La disfagia puede aparecer con cuerpos extraños en hipofaringe, pero más frecuentemente se encontrarán en esófago. Si el paciente presenta disnea o estridor, avisaremos a ORL.

La naturaleza del cuerpo extraño también es algo a considerar. Lo más frecuente es encontrarlos con espinas de pescado y huesos de otros animales, como pollo o conejo. Otros cuerpos

extraños, como verduras o plásticos, aunque pueden producir molestias, es más difícil que permanezcan en la orofaringe o hipofaringe. Por otra parte, las impactaciones esofágicas suelen estar causadas por bolos cárnicos.

Exploración

Primero hacemos una exploración orofaríngea. Pediremos al paciente que mantenga la lengua dentro de la boca y la relaje, mientras nosotros la presionamos con uno o dos depresores. Buscaremos en las amígdalas, los pilares amigdalinos, la orofaringe y la base de la lengua. Para explorar esta última zona, nos ayudará colocarnos algo por encima del paciente y presionar con firmeza la lengua. Aun así, para explorarla en su totalidad, es necesario hacer una laringoscopia indirecta. Es importante no confundir el caseum amigdalor o tonsilolitos con cuerpos extraños.

Podemos utilizar la palpación para ayudarnos en la exploración: con un dedo tocaremos la base de lengua, amígdalas y las paredes de la faringe. Puede que notemos nosotros mismo el cuerpo extraño, o más frecuentemente, que al palpar determinada zona el paciente indique que ahí nota un pinchazo. Esto nos ayudará a determinar su localización.

Para explorar la hipofaringe, epiglotis y glotis, también hay que hacer una laringoscopia indirecta o una fibroscopia. Si no encontramos el cuerpo extraño en la exploración orofaríngea y tenemos sospecha de que éste existe, llamaremos al especialista ORL para que las realice. Si hay sospecha de impactación esofágica, avisaremos al especialista en Digestivo para valorar una endoscopia.

Si la sospecha es baja podemos dar de alta al paciente con tratamiento antiinflamatorio durante 2 o 3 días, advirtiéndole que acuda de nuevo si aparece algún síntoma de alarma: fiebre, tortícolis, dolor o inflamación cervical. Si la sensación persiste, derivaremos al paciente a consultas ORL para una exploración faríngea completa de manera reglada.

Salvo que sospechemos un cuerpo extraño metálico, la radiografía simple tiene una baja sensibilidad, por lo que no debe pedirse de entrada (2) (3). El uso del bario como contraste mejora la sensibilidad de ésta, pero complica una eventual endoscopia, por lo que se desaconseja. Si hay sospecha de perforación esofágica se debe pedir TC.

Tratamiento en urgencias

Si encontramos el cuerpo extraño en las amígdalas o la orofaringe, lo extraeremos con unas pinzas. El reflejo nauseoso puede dificultarnos la tarea. Para reprimirlo es útil indicar al paciente que respire solo por la boca, con respiraciones largas y continuas y también utilizar anestésicos tópicos. Si encontramos la espina en la base de la lengua, también podremos retirarla mediante unas pinzas largas, como las de bayoneta. Deprimiremos con firmeza la lengua y deslizaremos sobre ella las pinzas hasta llegar a la base.

Si el cuerpo extraño se encuentra más abajo, será el ORL quien lo extraiga mediante laringoscopia indirecta y pinzas curvas o con fibroscopio con canal de trabajo. En ocasiones no es posible y es necesario retirarlo con un laringoscopio rígido, bajo sedación o anestesia general.

Al retirar el cuerpo extraño debe desaparecer o reducirse mucho el dolor. Si persisten algunas molestias pueden ser tratadas con antiinflamatorios. Después de la retirada, si no hay complicaciones, el paciente puede ser dado de alta.



Bibliografía

- Merino Gálvez E, Cuerpos extraños en el área ORL: Rodríguez Domínguez FJ, Rodríguez Herrero D, editores. En: Manual de otorrinolaringología práctica para medico de atención primaria. 1 edición. Jaén: Editorial Formación Alcalá; 2009.p.766-70.
- V Gautam, J Phillips, H Bowmer, and M Reichl. Foreign body in the throat. J Accid Emerg Med. 1994
- Lue AJ1, Fang WD, Manolidis S. Use of plain radiography and computed tomography to identify fish bone foreign bodies. Otolaryngol Head Neck Surg. 2000 Oct;123(4):435-8.